

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5103428-98.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: MILENIA DOS SANTOS SILVA E SILVA

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE NITERÓI

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

MEDIDA DE URGÊNCIA. SAÚDE. ADENOCARCINOMA DE COLON. QUADRO INDICATIVO DE METÁSTASE E LESÃO QUE PODE IMPORTAR OBSTRUÇÃO INTESTINAL. PERICULUM IN MORA CONFIRGURADO. PRAZO DE 60 DIAS PARA INÍCIO DO TRATAMENTO. LIMINAR DEFERIDA PARA AGENDAMENTO DA PRIMEIRA CONSULTA EM COLOPROCTOLOGIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, confirmando a liminar anteriormente concedida, para determinar que os réus, dentro de suas esferas de competência, agendem para a parte autora a consulta ambulatorio 1ª vez - coloproctologia (oncologia). Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, dê-se baixa e archive-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2025.

5103428-98.2024.4.02.5101

510015372562 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5103428-98.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: MILENIA DOS SANTOS SILVA E SILVA

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE NITERÓI

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta pela parte autora em face da decisão do juízo que indeferiu, por ora, a tutela de urgência nos seguintes termos (evento 3, DESPADEC1):

"Trata-se de ação proposta em face do ESTADO DO RIO DE JANEIRO, do MUNICÍPIO DE NITERÓI e da UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, por meio da qual pretende a parte autora a condenação das rés à obrigação de fazer, a saber, "que seja determinado aos réus que encaminhem imediatamente a autora para hospital com serviço de Oncologia a fim de que realize tratamento quimioterápico/radioterápico/cirúrgico, ou, na hipótese de inexistência de vaga na rede pública de saúde, para que seja o tratamento realizado na rede privada, às expensas dos requeridos".

Alega que "no dia 19/11/2024, a autora foi diagnosticada com ADENOCARCINOMA DE CÓLON EIV (METÁSTASES HEPÁTICAS) E SINAIS DE SUBOCLUSÃO INTESTINAL (CID C18). Por esta razão, necessita urgentemente ser encaminhada para hospital com serviço de Oncologia a fim de realizar tratamento quimioterápico/radioterápico/cirúrgico".

*É o breve relatório. **DECIDO.***

Conforme disposto no artigo 300, caput, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da probabilidade do direito.

A saúde é um direito social fundamental, mas a sua implementação deve ser regulamentada pelos entes competentes para que alcance de maneira justa e isonômica a coletividade. A intervenção do Poder Judiciário deve ser excepcional e em casos de flagrante ilegalidade.

A Lei 12.732/12 estabelece o prazo de **60 dias** para que seja iniciado o tratamento de paciente com neoplasia maligna:

Art. 2º O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único.

No caso concreto, verifica-se que o laudo médico, mais remoto, no qual consta o diagnóstico da autora, bem como o encaminhamento para hospital com recurso de cirurgia geral e oncologia, é datado de **13/11/2024** (evento 1, ANEXO5, fl.1), mesmo data em que foi realizado o exame anátomo patológico (fl.4), ou seja, não houve sequer o transcurso do prazo de 60 dias para que os réus pudessem organizar o início do tratamento da autora.

Ressalta-se ainda que a regulação da demandante foi feita em **19/11/2024**, tendo sido considerada "paciente apta, aguardando vaga" em **25/11/2024** (fls.6-7), ou seja, apenas 10 dias antes do ajuizamento da presente ação.

Esclareça-se que o Sistema Estadual de Regulação permite que os réus tenham conhecimento do estado de saúde do administrado e, diante das informações colhidas (como o tipo de doença, o local do domicílio do requerente e a disponibilidade de vagas da instituição de saúde), seja possível agendar a data para a primeira consulta na localidade mais próxima, capaz de prestar atendimento com maior eficiência e rapidez.

Nesse sentido, confira-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. SUS. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. ATENDIMENTO INICIADO POR FORÇA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONTINUIDADE. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. (...) 3. **O direito à saúde, positivado no art. 196 da Constituição, não significa acesso irrestrito a todo tipo de assistência médico-hospitalar, sem juízo de ponderação e indiscriminadamente, comprometendo a governança das redes públicas de saúde, e vulnerando o ideal republicano da igualdade de todos perante a lei.** 4. **O Poder Judiciário só pode intervir nos critérios do SUS para afastar ilegalidades, sendo insuficientes a tal desiderato a mera exibição de laudos médicos, particulares ou oficiais, visto que na saúde pública os tratamentos sujeitam-se a múltiplos fatores, a saber: indisponibilidade momentânea do tratamento ou falta de leitos hospitalares; carência de recursos orçamentários; limitações terapêuticas e de ofertas de remédios; insuficiência de médicos, enfermeiros e auxiliares; a fase evolutiva de medicamentos até a sua aprovação definitiva pelos órgãos competentes.** 5. **O paciente com câncer será encaminhado diretamente a hospital ou clínica Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON), capacitada para tratar os tipos mais comuns no Brasil, ou a um Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON), que trata qualquer tipo; ou ao Instituto Nacional do Câncer (Inca), no Rio de Janeiro, se assim for indicado por unidade autorizada do sistema de referências do centro, devendo apresentar exames específicos, comprovando a doença. Cadastrado no SISREG, passará por uma nova triagem, que 1 determinará a necessidade de tratamento oncológico naquele local.** 6. **No caso, à época da decisão que antecipou os efeitos da tutela, não havia sido ultrapassado o termo legal fixado pela Lei 12.732/12 para que a Administração cumprisse sua obrigação de iniciar o tratamento oncológico da autora.** Contudo, no contexto vivido pela paciente, 74 anos de idade, com doença em estágio avançado, inclusive com avanço em coluna lombar, e relatos de fortes dores, não é razoável interromper o tratamento, sob risco potencial à sua saúde, com possibilidade de progressão tumoral e redução drástica de sobrevida. Precedente da Turma. 7. Deve ser afastada, porém, a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios, visto que, não fosse a situação fática consolidada, a hipótese seria de reforma da sentença à ausência de ofensa ao prazo de 60 dias previsto na Lei 12.732/12 para início do tratamento oncológico da autora. 8. Remessa necessária desprovida e apelações parcialmente providas. (TRF2, Apelação 0135732-24.2013.4.02.5102, 7ª TURMA ESPECIALIZADA, DJE 20/02/2020, Des. Relatora NIZETE LOBATO CARMO) grifos nossos.

Ademais, o Enunciado nº 51 do Conselho Nacional de Justiça dispõe que: "nos processos judiciais, a caracterização de urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato", entendendo que a documentação médica acostada aos autos (evento 1, ANEXO4, fl.15 e anexo1, evento 1, ANEXO5, fl.1), por si só, não supre o determinado no referido Enunciado.

Não é possível concluir, portanto, que o caso da autora é mais urgente do que os outros pacientes que aguardam por atendimento na fila, o que afasta, em cognição sumária, a probabilidade do direito da demandante.

Ante o exposto, **INDEFIRO por ora** o requerimento de tutela de urgência."

Na mesma decisão, o juízo determinou a intimação do NAT para que o mesmo emita parecer sobre a transferência solicitada, bem como sobre a urgência, imprescindibilidade, pertinência e eficiência em relação à moléstia apresentada. O prazo para o NAT está em aberto até o dia 13/12 (Evento 5 dos autos originários).

Em seu recurso, a parte autora reitera a gravidade do seu caso visto que apresenta risco de obstrução intestinal, sendo que o laudo médico atesta risco de óbito por progressão de neoplasia e lentidão para início de quimioterapia. Sustenta que mesmo após um mês da confirmação do diagnóstico, a parte autora continua em fila na posição nº 607.

VOTO

Nos autos originários a parte autora junta laudo médico particular datado de 26/11/2024, atestando ser a mesma portadora de adenocarcinoma de cólon EIV (metástases hepáticas) e sinais de suboclusão intestinal (evento 1, ANEXO4pag. 15)

Paciente : Milenia dos Santos Silva e Silva

Relatório oncológico

Encaminhamento paciente para cadastro com a máxima urgência em Serviço de Oncologia do SUS . Paciente possui adenocarcinoma de cólon EIV (metástases hepáticas) e sinais de suboclusão intestinal . Avaliar colectomia com colostomia paliativa . Há risco de óbito por progressão de neoplasia e lentidão para início de quimioterapia . Sugiro celeridade .

Att,
26/11/2024

Thiago Pontes Braga
Oncologista
CRM: 52.965.347

Consta também documento da Políclínica Almir Madeira de Madureira solicitando o encaminhamento da parte autora para hospital com recurso de cirurgia e oncologia devido a risco de obstrução intestinal, datado de 13/11/2024 (evento 1, ANEXO5 pag. 01)

O PREENCHIMENTO DE TODOS OS CAMPOS ACIMA É IMPORTANTE PARA O AGENDAMENTO DA CONSULTA	
S	RESUMO DA HISTÓRIA CLÍNICA:
O	Encaminhamento paciente de 67 anos, sexo F, que apresenta
L	lesão esclerosante ocupando toda a circunferência do sigmoido
I	e determinando redução de seu calibre, o que impede
C	a passagem do colonoscópio. Documentada por colonoscopia
T	subclasse 12/11/24 no 1 CHN. TC de abdome 12/11/24
A	com imagens hepáticas secundárias. A paciente necessita de
Ç	encaminhamento de forma célere para o Hospital
À	com recurso de cirurgia geral e Oncologia, devido a risco de
O	obstrução intestinal.
DATA	13/11/24
ASSINATURA E CARIMBO DO PROFISSIONAL:	Dra Sônia M. C. Gonçalves Clínica Médica CRM 52.65379-9
R	PARECER E CONDUTA:

E, por fim, exame anátomo patológico indicando o diagnóstico de adenocarcinoma de cólon, datado de 13/11/2024 (evento 1, ANEXO5 pag. 4)

Exame	Resultado	Valor de Referência
Data de Coleta/Recebimento: 13/11/2024		Hora Aproximada: 13:18 BRT
Anátomo Patológico (Código de Ordenação: IQ-24-17964)		(Método: Coloração por Hematoxilina e Eosina)
Relatório Macroscópico:		
Biópsia de cólon sigmoide:		
O material é recebido em formalina e consiste de múltiplos fragmentos teciduais irregulares, medindo em conjunto 0,5 x 0,4 x 0,2 cm, constituídos por tecido elástico e pardo-acastanhado. Todo o material foi submetido a estudo histológico - 1B/MF.		
1B/MF/11		
Diagnóstico:		
Biópsia de cólon sigmoide:		
- Adenocarcinoma moderadamente diferenciado (baixo – OMS 2019), ulcerado, infiltrando mucosa colônica.		
- A neoplasia infiltra submucosa nesta amostra.		
- Ausência de componente adenomatoso nesta amostra.		
- Mucosa colônica adjacente reativa.		
Nota: Estudo imuno-histoquímico em andamento, para determinação do estado de expressão das Enzimas de reparo dos erros de pareamento do DNA (MMR: MLH1, MSH2, MSH6 e PMS2).		
Exame analisado por:	Dr. Carlos Guida dos Santos Filho CRM-RJ 5249609-6	

A Lei nº 12.732, de 22.11.2012, que dispõe sobre o primeiro tratamento do paciente com neoplasia maligna comprovada no âmbito do SUS, assim estabelece:

"Art. 2º O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único."

§ 1º Para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput, considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com o início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso."

Da mesma forma, a Portaria nº 876/13 do Ministério da Saúde, que regula a aplicação da Lei nº 12.732/12, prevê que:

"Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre a aplicação da Lei nº 12.732, de 22 de novembro de 2012, que versa a respeito do primeiro tratamento do paciente com neoplasia maligna comprovada, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)."

"Art. 2º Para fins desta Portaria, considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna comprovada com:

I - a realização de terapia cirúrgica;

II - o início de radioterapia; ou

III - o início de quimioterapia."

Parágrafo único. Os pacientes sem indicação das terapêuticas antitumorais descritas nos incisos I a III do "caput" terão acesso a cuidados paliativos, incluindo-se entre estes o controle da dor crônica, conforme protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde."

"Art. 3º O prazo de 60 (sessenta) dias fixado no art. 2º da Lei nº 12.732, de 2012, para fins do primeiro tratamento cirúrgico ou quimioterápico ou radioterápico do paciente no SUS, contar-se-á a partir do registro do diagnóstico no prontuário do paciente."

§ 1º O prazo previsto no "caput" poderá ser reduzido por profissional médico responsável, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único."

§ 2º Não se aplica o prazo previsto no "caput" aos seguintes casos de neoplasia maligna:

I - câncer não melanótico de pele dos tipos basocelular e espinocelular;

II - câncer de tireoide sem fatores clínicos pré-operatórios prognósticos de alto risco; e

III - casos sem indicação de tratamento descritos no art. 2º."

A legislação fala em 60 dias da confirmação do diagnóstico para início do tratamento, que compreende em realização de cirurgia ou início de radioterapia ou quimioterapia.

No entanto, isso não ocorrerá até que a parte autora passe pela 1ª consulta no ambulatório de oncologia, afim de que seja avaliado o tratamento necessário.

Ressalto que nos exames apresentados a parte autora está com o adenocarcinoma de colon devidamente confirmado em exame datado de 13/11/2024.

Assim, nos termos da legislação supracitada, a Autora deverá ter sua 1ª consulta marcada até 13/01/2025. E nesse sentido que a liminar deve ser concedida, sobretudo ante a proximidade do recesso e das férias dos advogados até o dia 20/01/2025, que ainda que não impeça a análise de questões urgentes, sem dúvida pode trazer dificultadores.

O *periculum in mora* resta configurado diante do próprio diagnóstico, com quadro já indicativo de metástase, além da existência de lesão que pode importar em obstrução intestinal.

Ressalto que em cumprimento a liminar deferida a União informou o agendamento junto ao Hospital Federal da Lagoa no dia 26/12/2024 (evento 21, OFIC2), o qual a parte autora informou ter comparecido nos autos originários (evento 23, PET1).

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, voto no sentido de CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, confirmando a liminar anteriormente concedida, para determinar que os réus, dentro de suas esferas de competência, agendem para a parte autora a consulta ambulatório 1ª vez - coloproctologia (oncologia). Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, dê-se baixa e archive-se.

